Diagnose-astma-en-medicatie

Correct

Stel de diagnose astma bij patiënten met aanvalsgewijze dyspneu, expiratoir piepen of hoesten. Voor de diagnose is tevens 1 van de volgende bevindingen vereist:

- spirometrisch aangetoonde reversibiliteit (FEV_1-toename ten opzichte van de waarde vóór bronchusverwijding met ≥ 12% én ≥ 200 ml) tijdens klachten óf
- spirometrisch aangetoonde variabiliteit (toe- of afname van de FEV_1 met ≥ 12% én ≥ 200 ml, bij herhaalde meting na ten minste 4 weken) óf
- bronchiale hyperreactiviteit op basis van een positieve histamine- of metacholineprovocatietest

Let wel:

- normale longfunctie bij spirometrie sluit astma niet uit;
- astma is wel onwaarschijnlijk als ten tijde van dyspneuklachten bij spirometrie geen obstructie en reversibiliteit aanwezig zijn.
- reversibiliteit of variabiliteit sluit COPD niet uit. Maar een normale FEV_1/FVC-ratio na gestandaardiseerde bronchusverwijding wél.

Aangezien er bij deze spirometrie sprake is van reversibiliteit, is een 2e meting > 4 weken later, nu niet geïndiceerd.

- Overweeg bij twijfel over de diagnose astma en frequente benauwdheidssymptomen een bronchiale provocatietest.
- Stel de bronchiale provocatietest 6 weken uit, als de patiënt een bovensteluchtweginfectie heeft, ter vermindering van de kans op een fout-positieve uitslag.
- Een negatieve histamine/metacholinetest sluit astma nagenoeg uit.

In de 2e lijn gebruikt men soms een indirecte test (zoals mannitoltest) om meer zekerheid te krijgen over de diagnose astma.

In veel ziekenhuizen worden histamineprovocatietesten uitgevoerd. De bijwerkingen van histamine-inhalaties kunnen vervelend zijn, zoals:
- hoofdpijn
- dyspneu
- erythemateuze reactie
- heesheid

https://www.thuisarts.nl/astma/ik-word-onderzocht-voor-astma

Aanbevelingen bij overmatig SABA-gebruik:

- Benadruk een SABA alleen te gebruiken bij daadwerkelijk aanwezige klachten of voorafgaand aan inspanning.
- Leg uit dat veelvuldig SABA-gebruik een teken is van onvoldoende gecontroleerd astma, kan leiden tot verminderde werking (receptortolerantie) en een risico vormt voor het krijgen van een longaanval.

- Vraag na welke drempels er zijn voor dagelijks ICS-gebruik. Probeer eventuele incorrecte cognities zo veel mogelijk te corrigeren; let op TIP-aandachtspunten (worden toegelicht op de volgende pagina).
  - Stel bij overmatig SABA-gebruik de medicatie bij volgens het stappenplan. Indien er sprake is van overmatig gebruik is de aflevering van dosisaerosolen met 200 inhalaties erg royaal.
- Overweeg de voorgeschreven hoeveelheden te verkleinen als de gekozen toedieningsvorm dit toelaat.
  - Besteed afhankelijk van de ernst van het overmatige gebruik, mate van controle, mogelijkheden en opvattingen van de patiënt, aandacht aan de genoemde punten.
  - Evalueer na 6 weken tot 3 maanden.

- SABA wordt ook regelmatig gebruik bij topsport.

Tabel 5 Inhalatiecorticosteroïden voor astma bij volwassenen. Doseringen in microgram.

Inhalatiesteroïde	Lage (start)dosering	Intermediaire dosering	Hogere dosering (meestal tijdelijk)
Beclometason			
Aerosol	2 dd 200	2 dd 400	2 dd 500
Poeder	2 dd 200	2 dd 400	2 dd 800
Aerosol extrafijn	2 dd 100	2 dd 200	2 dd 400
Budesonide			
Aerosol	2 dd 200	2 dd 400	2 dd 800
Poeder	2 dd 200	2 dd 400	2 dd 800
Fluticasonpropionaat			
Aerosol	2 dd 125	2 dd 250	2 dd 500
Poeder	2 dd 100	2 dd 250	2 dd 500
Ciclesonide			
Aerosol	1 dd 80	1 dd 160	2 dd 320 (= maximum)